

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR) ATAU INTRA UTERINE DEVICE (IUD) PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN		
	No. Dokumen 537.5/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim setelah kelahiran placenta yang dilakukan pasca kelahiran spontan atau bedah sesar.	
Tujuan	Mencapai sasaran MDGs butir 5b tahun 2015 yaitu meningkatkan CPR dari 57% menjadi 65% dan menurunkan <i>Unmet need</i> dari 9,1% menjadi 5% serta meningkatkan persentase Pasangan Usia Subur peserta KB aktif sebesar 65% serta cakupan KB pascapersalinan 60%.	
Kebijakan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,keluarga berencana dan sistem informasi keluarga 2. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. PERMENKES RI No. 514 Tahun 2015 tentang manajemen pelayanan KB	
Prosedur	1. Persiapan alat a. Forsep/korentang b. Gunting c. Mangkuk untuk larutan antiseptic d. Sarung tangan steril e. Cairan antiseptic untuk membersihkan serviks f. Kassa g. Lampu untuk penerangan h. IUD 2. Lakukan persiapan klien/pasien a. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) b. Perkenalkan diri dan Dokter yang merawat c. Identifikasi pasien d. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan e. Atur posisi pasien dalam posisi lithotomi 3. Siapkan lingkungan a. Jaga privasi pasien dengan memasang sketsel / sampiran b. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman 4. Pelaksanaan Pemasangan AKDR/IUD post partum spontan a. Cuci tangan sebelum tindakan dan pakai sarung tangan b. Inseri IUD dalam 10 menit pasca kelahiran plasenta Pasang AKDR c. Inseri manual : IUD dipegang antara jari telunjuk dan jari tengah, benang IUD dipotong sepanjang 2 – 3 cm, tangan kontralateral operator berada di fundus, IUD diletakkan pada cavum uteri menyentuh fundus. Jepitan dilepaskan dan pelan – pelan tangan dikeluarkan dari cavum uteri, kemudian di berikan oksitosin dan metilergometrin (bila tidak ada kontraindikasi). a) Inseri dengan inserter : b) Atur letak leher baru pada tabung inserter sesuai	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR) ATAU INTRA UTERINE DEVICE (IUD) PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN		
	No. Dokumen 537.5/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 3
	dengan kedalaman kavum uteri sampai dengan fundus. Hati – hati memasukkan tabung inserter sampai teraba ada tahanan. c) Lepas lengan AKDR dengan menggunakan teknik menarik, atau keluar pendorong d) Setelah lengan AKDR lepas, dorong secara perlahan – lahan tabung inserter ke dalam kavum uteri sampai menyentuh fundus uteri. Dan secara pelan –pelan inserter dilepaskan. Kemudian diberikan oksitosin dan atau metilergometrin (bila tidak ada kontraindikasi) 5. Inseri dengan round forceps: asisten memegang speculum, IUD dilepas dari inserternya dan benang dipotong sepanjang 2 – 3 cm, dipegang dengan round forceps, secara hati-hati IUD dimasukkan ke dalam cavum uteri sampai dengan fundus dan secara pelan – pelan dilepaskan forsepnya dan ditarik keluar dari cavum uteri dan kemudian diberikan oksitosin dan atau metilergometrin bila tidak ada kontraindikasi Pemasangan pasca SC tekniknya sama dengan pemasangan secara manual, tetapi IUD dan tangan masuk melalui SBR. 6. pemasangan IUD post section cesarea Inseri IUD setelah langsung setelah kelahiran plasenta, pasang IUD pada fundus uteri, benang IUD diposisikan pada cervix 7. Rapikan Pasien dan bereskan Alat a) Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman b) Bereskan alat-alat yang tidak digunakan c) Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 8. Lakukan Evaluasi dan Dokumentasi a) Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien b) Dokumentasi tindakan pada rekam medik pasien Petunjuk bagi klien 1. Kembali memeriksakan diri setelah 4 -6 minggu pemasangan AKDR 2. Setelah bulan pertama pemasangan, hanya perlu memeriksa IUD apabila kram / kejang di perut bagian bawah, Perdarahan (spotting) diantara haid atau setelah senggama , Nyeri setelah senggama atau apabila pasangan mengalami tidak nyaman selama melakukan hubungan seksual 3. AKDR perlu dilepas setelah waktu yang ditentukan tetapi dapat dilakukan lebih awal apabila diinginkan Kembali ke fasilitas kesehatan apabila : - AKDR terlepas - Siklus terganggu - Terjadi pengeluaran cairan dari vagina yang mencurigakan adanya infeksi		
Unit Terkait	1. IKO 2. Maternitas		